



Cas cliniques

Urgences chirurgicales

Dr. MENOURA. R
Maitre-assistant Hepato-biliopancreatique
Service de chirurgie digestive et endocrinienne
E.H. DIDOUCHE MOURAD
CONSTANTINE 2025/2026

Homme de 65 ans.

- Antécédents : HTA bien équilibrée.
- Motif d'admission : arrêt des matières et gaz depuis 48 h.
- Douleurs diffuses, distension abdominale.
- Amaigrissement, troubles du transit chroniques

- Température : 37,8 °C, TA : 110/70 mmHg, FC : 96/min.
- Abdomen : distendu, tympanique, douloureux, pas de défense.
- Bruits hydroaériques diminués.
- Ampoule rectale vide.
- ASP: NHA plus haut que large

- De quel syndrome s agit-il ?

Occlusion intestinale basse (colique)

Hypothèses diagnostiques.....???

- Cancer du côlon gauche (sigmoïde ou descendant).
- Volvulus du sigmoïde.
- Sténose diverticulaire.
- Fécalome massif

Quels examens complémentaires demandez vous ?

Biologie :

- - NFS : anémie microcytaire.
- - Ionogramme : troubles hydro-électrolytiques.
- - CRP élevée.

Imagerie :

- Scanner abdomino-pelvien injecté

Signes radiologiques typiques

- - Distension colique en amont.
- - Haustrations visibles.
- - Absence d'air rectal.
- - Point d'arrêt tumoral net au niveau du sigmoïde

conduite à tenir en urgence

- - Hospitalisation en chirurgie.
- - Mise en condition :
- - Sonde nasogastrique.
- - Réhydratation, correction électrolytique.
- - Antibioprophylaxie.
- - Décision chirurgicale urgente

Options chirurgicales

- 1. Résection + anastomose primaire** si conditions locales favorables.
- 2. Procédure de Hartmann** :
 - Résection du sigmoïde tumoral.
 - - Colostomie terminale.
 - - Fermeture du moignon rectal.
- -3. Colostomie de dérivation** si inopérable.
- - 4. Pose de stent colique** (option palliative)

Choix opératoire

- - Dépend de :
- - L'état général du patient.
- - Le degré de distension colique.
- - L'existence d'une contamination péritonéale.
- - La faisabilité d'une anastomose sans tension

- **Présentation du patient**

- Madame B.K., âgée de 72 ans, sans antécédents chirurgicaux abdominaux, consulte aux urgences pour douleurs abdominales diffuses et distension évoluant depuis 72 heures, avec arrêt des matières et des gaz

- Hypertension artérielle bien contrôlée.
- Constipation chronique depuis plusieurs mois.
- Amaigrissement progressif (-6 kg en 3 mois).
- Asthénie, teint pâle, méléna occasionne

Examen clinique

- Température : 38 °C
- TA : 110/65 mmHg - FC : 100/min
- Abdomen distendu, tympanique, douloureux prédominant au flanc droit, sans défense.
- Bruits hydroaériques diminués.
- TR : ampoule vide, sans masse.
- Pas de hernie

Étiologies possibles.....?

- Cancer du côlon droit (causa principale)
- Tumeur iléo-cæcale
- Sténose inflammatoire (Crohn, tuberculose intestinale)

examens radiologiques a demander???????

- ASP
- SCANNER

TDM

- Masse ulcéro-bourgeonnante de 6 cm, sténosante.
- Atteinte de la sous-séreuse sans perforation.
- Présence de 3 ganglions sur 18 envahis.
- Pas de métastases

Donc c une masse qui est résécable....

- Quel sera votre attitude chirurgicale ?

Supposant que le scanner objectivait une masse du colon droit avec envahissement locorégional ; le rein , la paroi antérieur

Quel sera alors le geste opératoire ?

- Si résécable : **Hémi-colectomie** droite avec anastomose ileotransverse
- Si envahissement locorégional ;
 1. cour circuitant la masse anastomose **ileotransverse**
 2. **iléostomie**

Classer votre tumeur en se basant sur le scanner

- I. T2N2M0
- II. T4N1M0
- III. T3N2M0
- IV. T3N1M0
- V. T1N1M0

Le cholestase hépatique est caractérisée par :

- 1. Augmentation PH-ALCALINE**
- 2. Diminution des GGT**
- 3. Augmentation modérée des ALAT/ASAT**
- 4. Augmentation TP**
- 5. Augmentation du cholestérol total**

Cas clinique

- Un homme de 68 ans, sans antécédent chirurgical, consulte pour un **arrêt des matières et des gaz depuis 3 jours** avec **douleurs abdominales diffuses** et **distension abdominale**. Il présente une **constipation chronique** ancienne et a déjà eu des épisodes similaires spontanément résolutifs.

- **Diagnostic le plus probable**

A. Occlusion intestinale haute

B. Volvulus du côlon pelvien

C. Occlusion tumorale du côlon gauche

D. Iléus paralytique

- – **Terrain prédisposant classique**

- A. Sujet jeune sportif

- B. Sujet âgé constipé et alité

- C. Antécédent de chirurgie colique

- D. Femme enceint

- **Signe typique à l'ASP**

- A. Niveau hydro-aérique grêlique

- B. Image en double jambage de botte ou en U inversé

- C. Pneumopéritoine

- D. Disparition des haustrations

- **Signe scanner spécifique**

- A. Dilatation grêlique avec transition iléale
- B. Whirl sign aspect en tourbillon
- C. Présence de liquide libre abondant
- D. Épaississement pariétal colique diffus

- **Premier geste thérapeutique en urgence (si non compliqué)**

A. Laparotomie exploratrice immédiate

B. Détorsion endoscopique par rectosigmoïdoscopie souple

C. Lavement baryté

D. Résection colique d'emblée

- **Attitude après succès de la détorsion endoscopique**

A. Sortie le lendemain sans suivi

B. Surveillance hospitalière + chirurgie différée prophylactique

C. Antibiothérapie seule

D. Lavement de contrôle

• **Quelle complication impose la chirurgie en urgence ?**

A. Constipation persistante

B. Ischémie et nécrose colique

C. Distension abdominale isolée

D. Vomissements

- **Type de chirurgie en cas de volvulus compliqué**

A. Sigmoidectomie simple avec anastomose immédiate

B. Intervention de Hartmann

C. Colectomie droite

D. Lavement évacuateur

- **Risque principal après une simple détorsion sans chirurgie**
- A. Fistule digestive
- B. Péritonite
- C. Récidive du volvulus
- D. Hémorragie digestive

• **À propos du volvulus du côlon pelvien, cochez la ou les affirmations vraies :**

A. C'est la cause la plus fréquente d'occlusion colique chez le sujet âgé.

B. Le diagnostic est radiologique.

C. La détorsion endoscopique suffit toujours.

D. Une chirurgie préventive est recommandée après un premier épisode.

- **Évolution typique sans traitement**

- A. Résolution spontanée

- B. Ischémie, nécrose puis perforation colique

- C. Simple constipation fonctionnelle

- D. Fistule colovésicale

Cas clinique

- Un homme de **32 ans**, sans antécédent particulier, est admis aux urgences après un **accident de moto**.
Il se plaint d'une **douleur abdominale latéralisée à gauche**, avec **sueurs froides** et **pâleur**.
- À l'examen :
- TA = 90/60 mmHg
- FC = 118 bpm
- Abdomen distendu, défense au flanc gauche
- Ecchymose pariétale (« marque de ceinture »)

• **Quelle est la priorité initiale à l'admission ?**

A. Réaliser un scanner abdomino-pelvien

B. Poser une sonde gastrique

C. Évaluer la stabilité hémodynamique

D. Effectuer un toucher rectal immédiatement

• **Quelle hypothèse diagnostique est la plus probable ?**

A. Péritonite appendiculaire

B. Rupture splénique

C. Traumatisme hépatique

D. Lésion de la vessie

• Quel est l'examen d'imagerie à effectuer en premier ?

- A. Scanner abdomino-pelvien avec injection
- B. Radiographie d'abdomen sans préparation (ASP)
- C. Échographie FAST (Focused Assessment with Sonography for Trauma)
- D. IRM abdominale

• **Le FAST montre un liquide libre abdominal.
Quelle est la prochaine étape ?**

A. Laparotomie immédiate

B. Scanner injecté si le patient reste stable

C. Lavage péritonéal diagnostique

D. Observation simple sans imagerie

- **Le scanner montre une rupture splénique stade III (AAST) avec hémopéritoine modéré sans extravasation active. Quelle conduite adopter ?**

A. Traitement chirurgical d'emblée

B. Embolisation splénique urgente

C. Surveillance clinique et hémodynamique

D. Splénectomie systématique

- **Quels sont les critères d'échec du traitement conservateur ?**

A. Chute de l'hémoglobine sous 8 g/dL malgré transfusion

B. Douleur abdominale persistante sans modification de la tension

C. Fièvre isolée

D. Résorption lente de l'hématome à l'échographie

Quelle intervention chirurgicale est indiquée en cas d'échec ?

- A. Splénorraphie**
- B. Splénectomie totale**
- C. Colectomie gauche**
- D. Laparoscopie exploratrice sans geste**

• **Quelle complication post-opératoire majeure redouter après splénectomie ?**

A. Hémorragie digestive

B. Infection fulminante à germes encapsulés

C. Fistule pancréatique

D. Occlusion intestinal

• **Quelle vaccination est indispensable avant la sortie du patient splénectomisé ?**

A. Hépatite B

B. BCG

C. Pneumocoque, méningocoque, Haemophilus

D. Tétanos

• **Quelles sont les indications chirurgicales formelles dans le traumatisme abdominal fermé ?**

- A. Instabilité hémodynamique persistante
- B. Pneumopéritoine au scanner
- C. Extravasation active de contraste
- D. fréquence cardiaque stable